



# INFORME TÉCNICO

## Casos confirmados de VSR en menores de 1 año y antecedente de vacunación materna

Río Gallegos, 14 de septiembre de 2026

### 1. Introducción

A solicitud de la Subsecretaría de Abordaje Comunitario de la Salud, se presenta el análisis de casos confirmados de IRAG e IRAG extendida por Virus Sincial Respiratorio (VSR) en menores de un año internados en el Hospital Regional Río Gallegos.

Se priorizaron los registros de la Unidad Centinela por su mayor completitud para las variables de interés. Los resultados corresponden a los casos captados por esta unidad y no representan la totalidad de los casos de la provincia de Santa Cruz.

El análisis comprende 46 casos registrados entre la semana epidemiológica 18 de 2024 y la semana epidemiológica 32 de 2026. Se describe su distribución por año y grupo etario, el antecedente de vacunación materna contra VSR y la semana gestacional de aplicación consignada en los registros.

### 2. Metodología

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo a partir de registros nominales de la Unidad Centinela de IRAG del Hospital Regional Río Gallegos, exportados del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

Se incluyeron menores de un año con clasificación de caso como IRAG o IRAG extendida, con resultado positivo para Virus Sincial Respiratorio (VSR) y con el mencionado hospital como establecimiento de internación.

El período analizado comprendió desde la SE 18 de 2024 hasta la SE 32 de 2026, según año y semana epidemiológica de internación consignados en la base. Se verificó que los 46 registros seleccionados tuvieran identificadores de evento completos y sin duplicaciones. La edad en meses se agrupó en 0-3, 4-6 y 7-11 meses.

El antecedente de vacunación materna contra VSR se clasificó como madre vacunada, madre no vacunada o sin dato, según la información registrada en la base. Entre los casos con antecedente de vacunación materna, se describió la semana gestacional de aplicación consignada.

El procesamiento se realizó en R. Los resultados se presentan como frecuencias absolutas por año. Los períodos 2024 y 2026 son parciales, por lo que los recuentos no son comparables en términos de incidencia anual.

Las definiciones de caso de IRAG e IRAG extendida, los criterios de inclusión y los procedimientos de la estrategia de vigilancia se encuentran detallados en la Guía Operativa UC-IRAG del Ministerio de Salud de la Nación (2024).[1]



### 3. Resultados

Durante el período analizado se identificaron 46 casos confirmados de VSR en menores de un año internados por IRAG o IRAG extendida en el Hospital Regional Río Gallegos: 30 en 2024, 15 en 2025 y 1 en 2026 (hasta SE 32, datos parciales).

#### 3.1. Distribución por año y grupo etario

Del total de casos, 18 correspondieron al grupo de 0–3 meses, 11 al de 4–6 meses y 17 al de 7–11 meses.

**Tabla 1:** Casos confirmados de VSR en menores de un año, según grupo etario y año. Hospital Regional Río Gallegos, SE 18/2024 a SE 32/2026.

| Grupo etario | 2024      | 2025      | 2026     | Total     |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 0–3 meses    | 13        | 5         | 0        | 18        |
| 4–6 meses    | 9         | 2         | 0        | 11        |
| 7–11 meses   | 8         | 8         | 1        | 17        |
| <b>Total</b> | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>1</b> | <b>46</b> |

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0. Nota: los datos de 2024 comprenden desde la SE 18 y los de 2026 hasta la SE 32.

#### 3.2. Antecedente de vacunación materna contra VSR

Entre los 46 casos confirmados de VSR, se registraron 3 con antecedente de madre vacunada, 40 de madre no vacunada y 3 sin dato sobre vacunación materna. El único caso incluido en 2026 no contaba con información sobre este antecedente.

**Tabla 2:** Antecedente de vacunación materna contra VSR en menores de un año con infección confirmada, según año. Hospital Regional Río Gallegos, SE 18/2024 a SE 32/2026.

| Antecedente materno | 2024      | 2025      | 2026     | Total     |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Madre vacunada      | 2         | 1         | 0        | 3         |
| Madre no vacunada   | 27        | 13        | 0        | 40        |
| Sin dato            | 1         | 1         | 1        | 3         |
| <b>Total</b>        | <b>30</b> | <b>15</b> | <b>1</b> | <b>46</b> |

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0.

#### 3.3. Semana gestacional de vacunación materna

Entre los tres casos con antecedente de vacunación materna, dos tenían registrada la aplicación en la semana gestacional 32, correspondientes a 2024, y uno en la semana 36, correspondiente a 2025.



**Tabla 3:** Semana gestacional de aplicación de la vacuna materna entre los casos con antecedente de vacunación, según año. Hospital Regional Río Gallegos, SE 18/2024 a SE 32/2026.

| Semana gestacional | 2024     | 2025     | 2026     | Total    |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 32 semanas         | 2        | 0        | 0        | 2        |
| 36 semanas         | 0        | 1        | 0        | 1        |
| <b>Total</b>       | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>3</b> |

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0. Nota: se incluyen únicamente los tres casos con antecedente de vacunación materna registrado.

#### 4. Limitaciones

Los resultados corresponden a los casos captados por la Unidad Centinela del Hospital Regional Río Gallegos y no representan la totalidad de los casos de la provincia de Santa Cruz.

La base utilizada no dispone de la fecha de aplicación de la vacuna materna contra VSR, por lo que no fue posible describir esta variable ni calcular el intervalo entre vacunación y nacimiento.

El antecedente de vacunación materna se describe según la información consignada en los registros, manteniendo diferenciados los casos sin dato. La información disponible no permite establecer los motivos de ausencia de vacunación materna ni su relación con el período de campaña, el acceso a controles prenatales o posibles omisiones en el registro de dosis aplicadas en el ámbito privado.

Estos resultados no permiten estimar la cobertura de vacunación en personas gestantes ni evaluar la efectividad o el impacto poblacional de la estrategia de vacunación.

---

Elaboración técnica

Área de Epidemiología MSyA

Coordinación Provincial de Redes de Laboratorio

#### Referencias

1. Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (Grave). Guía Operativa 2024. Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia-uc-irag-vff.pdf>